

TEMA 8

Incapacidad temporal: concepto y causas que motivan esta situación. Beneficiarios.

Prestación económica: determinación y cuantía. Nacimiento, duración y extinción del derecho al subsidio. Reconocimiento y pago.

Control de la incapacidad. Incapacidad permanente contributiva: concepto. Grados de incapacidad. Prestaciones. Determinación y cuantía. Beneficiarios. Nacimiento, duración y extinción del derecho. Lesiones permanentes no incapacitantes. La calificación y revisión de la incapacidad permanente.

Cuerpo: Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social

Subgrupo y acceso: C1 · sistema general de acceso libre

Actualización: 30 de julio de 2026

Programa: Anexo I de la Resolución de 22 de diciembre de 2025

AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2026 ACADEMIA LORMAN. Todos los derechos reservados.

Material protegido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, modificación, venta, cesión, publicación o difusión, total o parcial, sin autorización previa y por escrito de su titular.

No está permitida su publicación en páginas web, plataformas digitales, redes sociales, grupos de mensajería, aplicaciones, repositorios o servicios de intercambio de archivos.

Contenido actualizado y revisado a fecha de 30 de julio de 2026.*Contenido actualizado a 30 de julio de 2026.*

La incapacidad temporal —IT— protege una pérdida transitoria de capacidad laboral; la incapacidad permanente contributiva —IP— atiende reducciones objetivables y previsiblemente definitivas. Ambas pueden proceder de contingencias comunes o profesionales, pero difieren en concepto, duración, cuantía, gestión y efectos laborales. El núcleo legal se encuentra en los artículos 169 a 176 y 193 a 203 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social —TRLGSS—, completados por el Real Decreto 625/2014, el Real Decreto 1300/1995 y la normativa reglamentaria histórica que continúa vigente.

1. Incapacidad temporal: concepto

La IT ordinaria exige simultáneamente:

1. enfermedad común o profesional, o accidente laboral o no laboral;
2. asistencia sanitaria de la Seguridad Social;
3. impedimento para realizar el trabajo;
4. duración dentro de los límites legales.

Una patología diagnosticada no basta si no impide trabajar. A la inversa, el impedimento debe guardar relación con un proceso que requiere asistencia sanitaria. La valoración se hace respecto del trabajo que desempeña la persona, sus exigencias reales y el estado clínico, no sobre una incapacidad abstracta para cualquier actividad.

La situación ordinaria dura como máximo 365 días, prorrogables hasta 180 días más si se presume que durante la prórroga puede producirse alta por curación o mejoría. El límite ordinario del subsidio es, por tanto, 545 días naturales, aunque después pueda existir prolongación de efectos económicos mientras se califica la IP.

También es IT el período de observación por enfermedad profesional cuando se prescribe baja laboral para estudiar y diagnosticar: dura hasta 180 días, prorrogables por otros 180 si es necesario.

2. Situaciones especiales de incapacidad temporal

El artículo 169.1.a) incorpora cuatro situaciones especiales por contingencias comunes:

2.1. Menstruación incapacitante secundaria

Es la incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patología previamente diagnosticada. Cada baja constituye un proceso nuevo: no se suma como recaída a efectos del máximo aunque se produzca por la misma situación dentro de los 180 días siguientes.

No se exige período mínimo de cotización. El subsidio corre a cargo de la entidad gestora o colaboradora desde el mismo día de la baja. Su cuantía sigue la escala general de la IT por contingencias comunes: 60 por ciento de la base reguladora del día 1 al 20 y 75 por ciento desde el 21, aunque la norma desplaza el nacimiento del pago al día primero.

2.2. Interrupción del embarazo

La interrupción, voluntaria o no, es situación especial mientras la trabajadora recibe asistencia del servicio público de salud y está impedida. Si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se califica como contingencia profesional.

En su configuración común no requiere carencia. La entidad responsable paga desde el día siguiente a la baja y el empresario soporta el salario íntegro del día de la baja.

2.3. Gestación desde el primer día de la semana trigésima novena

Es IT especial desde el día primero de la semana 39 hasta el parto. Exige la carencia prevista para nacimiento y cuidado según la edad:

- menos de 21 años: ninguna;
- desde 21 y menos de 26: 90 días en los 7 años anteriores o 180 en toda la vida laboral;
- 26 o más: 180 días en los 7 anteriores o 360 en toda la vida laboral.

El subsidio nace al día siguiente de la baja y el empresario paga el salario del día inicial. Termina en la fecha del parto. Si ya existía riesgo durante el embarazo, se mantiene esa prestación mientras proceda: no se sustituye por la IT de semana 39.

2.4. Donación de órganos o tejidos para trasplante

Desde el 3 de marzo de 2025, la donación por persona viva es situación especial durante los actos preparatorios necesarios, la hospitalización, la intervención y la recuperación hasta el alta por curación. Debe existir imposibilidad para el trabajo.

No se exige carencia. El subsidio nace el mismo día de la baja, lo paga desde ese día la entidad que cubre las contingencias comunes y alcanza el 100 por ciento de la base reguladora de IT por contingencias comunes. Es la excepción cuantitativa más visible: no se aplica la escala 60/75.

Situación	Carencia	Inicio del subsidio	Cuantía
Menstruación incapacitante secundaria	No	Mismo día de baja	60 % / 75 %
Interrupción del embarazo común	No	Día siguiente	60 % / 75 %
Semana 39 de gestación	Según edad, art. 178	Día siguiente	60 % / 75 %
Donación de órganos o tejidos	No	Mismo día de baja	100 %

3. Recaída y nuevo proceso

Hay recaída cuando se produce una nueva baja por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes a los efectos del alta anterior. Los períodos se acumulan para calcular los máximos de 365 y 545 días.

No es recaída:

- la nueva baja por patología distinta, aunque se produzca inmediatamente;
- la baja por la misma patología después de superar el intervalo legal, sin perjuicio de las reglas tras agotamiento de 545 días;
- cada proceso de menstruación incapacitante secundaria, por expresa excepción.

Cuando el alta fue expedida por la inspección médica del INSS, solo esta puede emitir una nueva baja por la misma o similar patología dentro de los 180 días siguientes. Una baja emitida por otro facultativo en ese intervalo no desplaza la competencia exclusiva.

Después de agotados 545 días y resuelto el expediente de IP, un nuevo derecho por la misma o similar patología exige, como regla, más de 180 días desde la resolución y cumplimiento de nuevo de los requisitos. Para enfermedad común, solo cuentan para la nueva carencia las cotizaciones posteriores a aquella resolución. Excepcionalmente, antes de transcurrir 180 días, el INSS puede abrir por una sola vez un nuevo proceso si considera posible recuperar la capacidad laboral; la baja se acuerda exclusivamente a efectos económicos.

4. Beneficiarios y carencia

Son beneficiarias las personas incluidas en el Régimen General que estén en una situación del artículo 169, se encuentren afiliadas y en alta o asimilada y acrediten, cuando corresponda, la carencia.

Causa	Cotización mínima
Enfermedad común ordinaria	180 días en los 5 años anteriores
Accidente de trabajo	Ninguna
Accidente no laboral	Ninguna
Enfermedad profesional	Ninguna
Menstruación incapacitante secundaria	Ninguna
Interrupción del embarazo común	Ninguna
Donación	Ninguna
Semana 39	Carencia de nacimiento según edad

La IT se reconoce aunque la empresa haya incumplido cotización si concurren las reglas de protección y responsabilidad aplicables; no debe hacerse recaer mecánicamente sobre el trabajador por cuenta ajena una obligación empresarial.

Durante huelga y cierre patronal no se tiene derecho al subsidio económico de IT. La ausencia de pago no significa que desaparezcan todas las consecuencias sanitarias ni que una baja anterior se extinga sin aplicar su normativa; debe diferenciarse la situación de alta especial del devengo económico.

5. Base reguladora de la incapacidad temporal

5.1. Trabajadores con salario mensual

La base reguladora diaria por contingencias comunes se obtiene, con carácter general, dividiendo la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior a la baja entre:

- 30, si la retribución es mensual;
- el número de días a que corresponda la cotización —28, 29, 30 o 31—, si la retribución es diaria.

Si la persona ingresó en la empresa en el mismo mes de la baja, se toma la base de ese mes y se divide por los días efectivamente cotizados. Existen reglas específicas para contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos, artistas y otros colectivos.

Para contingencias profesionales se añade a la base profesional del mes anterior, sin horas extraordinarias, el promedio diario de las horas extraordinarias cotizadas durante los doce meses anteriores. El divisor sigue las reglas de cotización del período.

5.2. Trabajo a tiempo parcial

La base reguladora diaria resulta de sumar las bases de cotización acreditadas desde la última alta, con un máximo de los tres meses inmediatamente anteriores al hecho causante, y dividir las por los días naturales comprendidos en ese período. La prestación se abona por todos los días naturales de IT. Las reglas buscan evitar que el horario irregular desfigure la renta sustituida.

5.3. Base invariable y excepciones

La base reguladora queda normalmente fijada al inicio y no cambia porque suban después salarios o bases, salvo supuestos normativos como elevación retroactiva de bases por convenio, error o regularización procedente. El cambio del porcentaje al día 21 no modifica la base: modifica el porcentaje que se aplica.

Ejemplo común: base mensual anterior de 1.800 euros. Base diaria = $1.800 / 30 = 60$ euros. Por enfermedad común, del día 4 al 20 se devengan 36 euros diarios; desde el día 21, 45 euros. Los días 1 a 3 no generan subsidio salvo mejora.

Ejemplo profesional: base profesional sin horas extra de 2.100 euros y promedio mensual equivalente de horas extra de 90. Base diaria aproximada = $2.100 / 30 +$ promedio diario anual de horas extra. Sobre el resultado se aplica 75 por ciento desde el día siguiente a la baja.

6. Cuantía y nacimiento del subsidio

La escala general es:

Contingencia	Porcentaje	Desde cuándo
Enfermedad común y accidente no laboral	60 % de BR	Días 4 a 20
Enfermedad común y accidente no laboral	75 % de BR	Desde día 21
Accidente de trabajo y enfermedad profesional	75 % de BR	Día siguiente a la baja
Donación de órganos o tejidos	100 % de BR común	Mismo día de baja

En contingencias comunes ordinarias, los días 1 a 3 carecen de subsidio público. Del día 4 al 15, ambos incluidos, paga directamente el empresario; desde el 16 responde la entidad gestora o mutua, aunque la empresa pueda materializar el pago delegado.

En AT/EP, el empresario paga salario íntegro el día de la baja y el subsidio nace al siguiente. En interrupción del embarazo común y semana 39 sucede también que el día inicial es salario empresarial y el subsidio comienza al siguiente. En menstruación incapacitante y donación, la entidad paga desde el propio día de baja.

Un convenio colectivo puede mejorar las cuantías, pero el complemento es distinto del subsidio. La mejora no cambia la entidad responsable del porcentaje legal ni la fecha de nacimiento de la prestación pública.

7. Duración, prórroga y extinción

7.1. Cronología principal

Fase	Límite	Efecto
IT ordinaria	Hasta 365 días	Control compartido según competencias
Prórroga	Hasta 180 días	Automática si no hay alta al día 365
Máximo del subsidio	545 días	Extinción y examen de IP
Calificación ordinaria	Hasta 90 días	Evaluación obligatoria tras 545
Demora excepcional	Hasta máximo total 730 días	Si hay expectativa de recuperación

Desde el 17 de mayo de 2023, al llegar a 365 días sin alta se pasa automáticamente a prórroga; no se necesita una resolución expresa que la declare. La empresa mantiene el pago delegado

hasta que se le notifique el alta, hasta el último día del mes en que se expida alta con propuesta de IP o hasta el día 545, según el supuesto.

7.2. Causas de extinción

El subsidio se extingue por:

- alcanzar 545 días desde la baja;
- alta por curación o mejoría que permita el trabajo habitual;
- alta con o sin declaración de IP;
- reconocimiento de jubilación;
- incomparecencia injustificada a reconocimientos del INSS o de la mutua;
- fallecimiento.

También deben computarse recaídas. Un alta médica produce efectos laborales y económicos desde la fecha legal, sin que la mera impugnación suspenda siempre esos efectos; existen procedimientos especiales.

7.3. Calificación después de 545 días

Al agotarse el plazo, el INSS debe examinar el estado en un máximo de 90 días. Si continúa tratamiento y existe expectativa razonable de recuperación o mejoría para volver al trabajo, puede demorar la calificación, pero IT más prolongación nunca supera 730 días naturales.

Durante los 90 días de evaluación y la demora no subsiste obligación de cotizar. Si se prolongan los efectos económicos en los casos del artículo 174. El pago continúa hasta la notificación de la resolución de IP.

Si se reconoce IP, los efectos nacen en la fecha de la resolución, salvo que su importe sea superior a lo percibido durante la prolongación: entonces se retrotraen al día siguiente de extinguirse la IT. Si se deniega, concluye la prolongación según la resolución y procede la reincorporación, sin perjuicio de impugnación.

8. Pérdida, suspensión y fraude

El derecho puede denegarse, anularse o suspenderse si el beneficiario:

- actúa fraudulentamente para obtener o conservar el subsidio;
- trabaja por cuenta propia o ajena durante la IT.

Puede suspenderse si rechaza o abandona sin causa razonable el tratamiento indicado. La negativa debe valorarse con audiencia y proporcionalidad: no cualquier discrepancia terapéutica equivale automáticamente a abandono injustificado.

La incomparecencia a una cita de control del INSS o mutua provoca inicialmente suspensión cautelar para verificar si estuvo justificada. Si se aporta justificación válida en el plazo reglamentario, se rehabilita el pago; si no, puede extinguirse. Es incorrecto afirmar que toda falta a una cita produce extinción inmediata sin trámite.

9. Reconocimiento, gestión y pago

En enfermedad común y accidente no laboral, la cobertura corresponde normalmente al INSS o a la mutua elegida para contingencias comunes. En AT/EP, responde la entidad con la que la empresa tenga cubierta la contingencia profesional.

El servicio público de salud emite partes de baja, confirmación y alta dentro de sus competencias. Desde abril de 2023, la persona trabajadora no tiene que entregar a la empresa

la copia en papel: el sistema comunica electrónicamente los datos necesarios. La empresa transmite al INSS la información económica mediante los cauces reglamentarios.

La empresa paga por delegación la prestación ordinaria y compensa el importe en su liquidación, salvo:

- días 4 a 15 por contingencias comunes ordinarias, que son coste directo empresarial;
- pago directo en los supuestos legales —extinción del contrato, incumplimiento empresarial, determinados colectivos, agotamiento de pago delegado o solicitud procedente—;
- situaciones en que la mutua o entidad abona directamente.

Si el contrato termina durante la IT, la prestación no desaparece. Continúa en pago directo con reglas distintas según la contingencia y después se enlaza, en su caso, con desempleo. Debe evitarse mezclar el derecho a IT con la relación laboral que servía de soporte.

10. Control médico hasta y después de 365 días

Hasta 365 días:

- el servicio público de salud emite bajas, confirmaciones y altas médicas;
- la mutua ejerce control y puede emitir altas en procesos profesionales y propuestas de alta en comunes;
- la inspección médica del INSS puede emitir alta a todos los efectos;
- si el INSS da el alta, solo él puede acordar otra baja por patología igual o similar durante 180 días.

Agotados 365 días, la inspección médica del INSS es la única competente para:

- alta por curación;
- alta por mejoría que permita reincorporación;
- alta con propuesta de IP;
- alta por incomparecencia injustificada;
- nueva baja por igual o similar patología en los 180 días siguientes.

10.1. Disconformidad con alta del INSS tras 365 días

La persona puede manifestar disconformidad ante la inspección del servicio público de salud en el plazo de cuatro días naturales desde la recepción del alta. La inspección puede discrepar motivadamente en siete días. Si discrepa, el INSS reconsidera y decide en otros siete. Durante esta tramitación se prorroga la IT hasta la resolución definitiva con los efectos previstos.

No debe confundirse este procedimiento con la revisión de un alta de mutua antes de 365 días, que tiene su procedimiento específico, ni con la demanda judicial. Cada vía tiene plazo y efectos diferentes.

11. Incapacidad permanente contributiva: concepto

Existe IP cuando la persona, tras el tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales:

- graves;
- objetivamente determinables;
- previsiblemente definitivas;
- con efecto reductor o anulador sobre su capacidad laboral.

La posibilidad de recuperación no impide la calificación si médicamente es incierta o a largo plazo. Desde la Ley 3/2024, puede dispensarse el tratamiento previo cuando la patología, fase, evolución y gravedad permitan objetivar ya reducciones previsiblemente definitivas. También se admite que lesiones anteriores a la afiliación conduzcan a IP si, en una persona con discapacidad, se agravan después y disminuyen la capacidad que tenía al afiliarse.

La IP deriva normalmente de una IT. No es imprescindible cuando la persona carece de protección de IT en una situación asimilada, cuando se asimila a trabajador por cuenta ajena sin esa cobertura, al acceder desde no alta a absoluta o gran incapacidad, o cuando opera la excepción al tratamiento previo.

El diagnóstico por sí solo no fija el grado. Se valoran limitaciones funcionales y exigencias de la profesión habitual o de todo trabajo. Dos personas con la misma patología pueden recibir grados distintos por sus secuelas y tareas.

12. Grados de incapacidad permanente

El artículo 194 enumera cuatro grados:

1. incapacidad permanente parcial;
2. incapacidad permanente total;
3. incapacidad permanente absoluta;
4. gran incapacidad.

Desde el 1 de mayo de 2025 la denominación legal es gran incapacidad, no «gran invalidez».

Mientras no se desarrolle plenamente la nueva valoración porcentual, continúan operando las definiciones reglamentarias tradicionales:

Grado	Efecto funcional operativo	Prestación típica
Parcial	Disminución no inferior al 33 % del rendimiento normal, sin impedir tareas fundamentales	Indemnización de 24 mensualidades
Total	Inhabilita para todas o las tareas fundamentales de la profesión habitual, permite otra	Pensión del 55 %, incrementable
Absoluta	Inhabilita para toda profesión u oficio	Pensión del 100 %
Gran incapacidad	Además necesita ayuda de otra persona para actos esenciales de la vida	Pensión correspondiente + complemento

La profesión habitual se determina atendiendo a la contingencia y a la actividad real. En accidente suele ser la ejercida al ocurrir; en enfermedad se atiende a la actividad fundamental desarrollada en el período reglamentario. El grupo profesional y las tareas efectivas aportan el contexto; no basta el nombre contractual.

13. Beneficiarios y períodos de cotización de la IP

La persona debe estar declarada en un grado, reunir la condición general de afiliación y alta o asimilada y acreditar carencia cuando derive de enfermedad común. Por accidente, laboral o no, y enfermedad profesional no se exige período previo.

No se reconoce IP derivada de contingencias comunes a quien, en el hecho causante, ya tenga la edad ordinaria aplicable y cumpla los requisitos para jubilarse. Si no reúne jubilación, puede haber reglas específicas para IP a edad avanzada.

13.1. Incapacidad permanente parcial

Si deriva de enfermedad común, se exigen 1.800 días dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se extingue la IT de la que procede. Es un dato clásico de examen.

Para menores de 21 años existe una regla reglamentaria especial: debe cubrirse la mitad de los días transcurridos entre los 16 años y el comienzo de la IT, más todo el período, agotado o no, de IT.

13.2. Pensiones desde alta o situación asimilada

Por enfermedad común:

- si el causante tiene menos de 31 años, la tercera parte del tiempo transcurrido desde los 16 hasta el hecho causante;
- con 31 años o más, la cuarta parte del tiempo transcurrido desde los 20 hasta el hecho causante, con un mínimo de 5 años; al menos una quinta parte debe encontrarse en los 10 años anteriores.

Si se accede desde alta asimilada sin obligación de cotizar, los diez años para la carencia específica se cuentan hacia atrás desde el cese de la obligación.

Ejemplo: persona de 40 años. Desde los 20 han pasado 20 años; una cuarta parte son 5 años, que coincide con el mínimo. Debe situar al menos una quinta parte —1 año— dentro de los 10 anteriores al hecho causante o al cese de cotización si procede la regla especial.

13.3. Absoluta o gran incapacidad desde no alta

Las pensiones de absoluta o gran incapacidad por contingencias comunes pueden causarse sin alta o situación asimilada. Se exigen 15 años de cotización, con al menos la quinta parte en los 10 anteriores. La excepción no incluye parcial ni total.

Si se pretende causar pensión en varios regímenes desde no alta, las cotizaciones acreditadas en cada uno deben superponerse al menos durante 15 años. Esta regla evita obtener varias pensiones con períodos completamente sucesivos en la excepción.

14. Prestaciones por cada grado

14.1. Parcial

Consiste en una indemnización única equivalente, según el desarrollo reglamentario, a 24 mensualidades de la base reguladora utilizada para la IT de la que procede. Es compatible con continuar en el mismo trabajo, porque por definición no inhabilita para las tareas fundamentales.

No es una pensión. En consecuencia, no se aplica el porcentaje del 55 ni tiene pagos mensuales vitalicios.

14.2. Total

La prestación ordinaria es una pensión vitalicia equivalente al 55 por ciento de la base reguladora. Puede sustituirse excepcionalmente por indemnización a tanto alzado si el beneficiario es menor de 60 años y cumple los requisitos reglamentarios, entre ellos solicitud dentro del período previsto y expectativa de actividad compatible.

La total «cualificada» incrementa el porcentaje en 20 puntos, hasta el 75 por ciento, cuando la persona de 55 o más años, por edad, preparación y circunstancias sociales y laborales, tiene especial dificultad para encontrar empleo distinto. El incremento puede resultar incompatible con trabajos incluidos en la Seguridad Social.

La total derivada de enfermedad común tiene el mínimo anual específico fijado para titulares menores de 60 años con cónyuge no a cargo.

14.3. Absoluta

Consiste en pensión vitalicia del 100 por ciento de la base reguladora. La exención fiscal se analiza conforme a la normativa tributaria; no debe extrapolarse a otros grados.

Desde 22 de diciembre de 2024, si el pensionista realiza una actividad que determina inclusión en un régimen, la entidad suspende la pensión y la reanuda cuando cesa, sin perjuicio de revisar el grado. Pueden realizarse actividades compatibles con el estado que no revelen cambio de capacidad, pero la inclusión en Seguridad Social activa la suspensión legal.

14.4. Gran incapacidad

La persona percibe la pensión correspondiente —normalmente absoluta— más un complemento para remunerar a quien le presta ayuda. El complemento suma:

- 45 por ciento de la base mínima de cotización vigente al hecho causante;
- 30 por ciento de la última base de cotización correspondiente a la contingencia.

Nunca puede ser inferior al 45 por ciento de la pensión sin complemento. Si una actividad incompatible provoca suspensión de la pensión, el complemento de gran incapacidad no se suspende, por su finalidad asistencial.

15. Base reguladora de las pensiones de IP

La causa determina el cálculo. Después se aplica el porcentaje del grado.

15.1. Enfermedad común

Como regla para carencias de al menos ocho años:

1. se toman las 96 bases mensuales anteriores al mes previo al hecho causante;
2. se dividen entre 112;
3. las 24 bases más recientes se computan nominalmente;
4. las restantes se actualizan por IPC;
5. al resultado se aplica el porcentaje de jubilación que corresponda a los años cotizados, contando como cotizados los años que faltan hasta la edad ordinaria;
6. si no se alcanzan 15 años, se aplica el 50 por ciento;
7. sobre la base reguladora resultante se aplica el porcentaje del grado.

Este doble porcentaje es una trampa frecuente. Primero se ajusta la base por carrera para enfermedad común y después se aplica 55, 75 o 100 según el grado.

Si la carencia exigida es inferior a ocho años, se toma un número de bases igual a los meses de carencia, con adaptación del divisor y sin actualizar las 24 más próximas.

Las lagunas de cotización en Régimen General se integran: las primeras 48 mensualidades con la base mínima aplicable y las restantes con el 50 por ciento de esa mínima. Hay reglas de integración parcial y de contratos a tiempo parcial. Esta integración no se traslada sin norma al RETA.

15.2. Accidente no laboral

Para una pensión desde alta se escogen, en general, 24 mensualidades ininterrumpidas dentro de los 7 años anteriores y se dividen entre 28. Si no se completan 24 meses consecutivos de bases, existen reglas alternativas. Para absoluta o gran incapacidad desde no alta se aplica la regla legal específica de 96/112.

15.3. Accidente de trabajo y enfermedad profesional

La base se determina con salarios reales conforme al Reglamento de Accidentes de Trabajo: sueldo y antigüedad, pagas extraordinarias, complementos y promedio de conceptos variables y horas extraordinarias. La finalidad es reflejar la retribución anual vinculada al trabajo.

No debe calcularse una pensión profesional tomando sin más la base común del mes anterior. Esa regla es propia de IT; la pensión de IP profesional usa un cálculo anual reglamentario.

15.4. Ejemplos

IPT común: si la base obtenida tras 96/112 es 1.600 euros y el porcentaje por carrera del artículo 197 es 80 por ciento, la base reguladora final es 1.280. La IPT ordinaria equivale a 704 euros —55 por ciento—, sin perjuicio de mínimos.

Gran incapacidad: si la pensión base es 1.500 euros, la base mínima aplicable 1.400 y la última base 2.000, el complemento calculado es $630 + 600 = 1.230$. El mínimo alternativo, 45 por ciento de 1.500, es 675; prevalece 1.230.

16. Nacimiento, duración, compatibilidad y extinción

La IP se reconoce mediante resolución del INSS. La fecha del hecho causante varía:

- si procede de IT extinguida por agotamiento, se conecta con la extinción y la resolución conforme a las reglas de prolongación;
- si no estuvo precedida de IT, suele fijarse en la fecha del dictamen-propuesta del equipo;
- desde no alta, la solicitud tiene relevancia conforme a la regla reglamentaria;
- en enfermedad profesional puede existir fecha específica.

Las pensiones son vitalicias mientras subsista el grado, pero revisables. «Vitalicia» no significa irrevocable.

16.1. Compatibilidad de la total

La IPT es compatible con salario en la misma u otra empresa siempre que las funciones no coincidan con las que originaron el reconocimiento. Debe comunicarse la actividad y puede promoverse revisión.

El incremento del 20 por ciento de la total cualificada puede ser incompatible con trabajo por cuenta propia o ajena incluido en el sistema. En ese caso se suspende el incremento, no necesariamente el 55 por ciento ordinario.

16.2. Absoluta y gran incapacidad

Son posibles actividades compatibles con el estado que no representen cambio de capacidad. Sin embargo, si el trabajo o actividad produce inclusión en Seguridad Social, se suspende la pensión mientras dure y se reanuda al cesar. El complemento de gran incapacidad se mantiene.

Desde la edad de jubilación, la compatibilidad se rige en términos análogos a la pensión de jubilación contributiva. A los 67 años, las pensiones de IP pasan a denominarse jubilación sin cambiar condiciones ni cuantía.

16.3. Efectos laborales tras la Ley 2/2025

La declaración de total, absoluta o gran incapacidad ya no extingue automáticamente el contrato. La persona dispone de 10 días naturales desde la notificación para manifestar por escrito que desea mantener la relación.

La empresa cuenta con un máximo de tres meses desde la notificación para:

- realizar ajustes razonables, necesarios y adecuados en el puesto;
- trasladar a una vacante compatible y disponible;
- o extinguir motivadamente si el ajuste supone carga excesiva, no existe vacante o se rechaza un cambio adecuado.

Durante ese período subsiste la suspensión con reserva. Si se desempeña un puesto adaptado u otro puesto incompatible con la pensión, esta se suspende en los términos del artículo 174.5 y del artículo 198.

La carga excesiva se valora considerando coste, tamaño, recursos, ayudas y efectos organizativos. En empresas de menos de 25 personas se aplica además el criterio legal específico relativo al coste de adaptación.

17. Lesiones permanentes no incapacitantes

Son lesiones, mutilaciones o deformidades:

- definitivas;
- causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional;
- incluidas en el baremo reglamentario;
- que alteran la integridad física;
- pero no alcanzan IP.

Se indemnizan una sola vez por la entidad que habría pagado la IP y permiten continuar al servicio de la empresa. El beneficiario debe estar en alta o asimilada y haber recibido alta médica.

Son incompatibles con prestaciones de IP cuando se valoran las mismas lesiones. Sí pueden coexistir si las lesiones baremadas son totalmente independientes de las que fundamentaron la IP.

Ejemplo: una pérdida anatómica baremada derivada de accidente profesional que no reduce al menos un 33 por ciento el rendimiento puede generar indemnización. Si esa misma pérdida fundamenta IPT, no se suman ambas. Una cicatriz independiente y baremada podría indemnizarse si no se tuvo en cuenta para el grado.

18. Calificación de la IP

El INSS tiene competencia exclusiva para declarar la IP a efectos económicos, cualquiera que sea la entidad que cubra la contingencia. El procedimiento del Real Decreto 1300/1995 puede iniciarse:

- de oficio por la entidad gestora;
- a petición de la inspección de trabajo o del servicio público de salud;
- por solicitud del interesado;
- a instancia de una mutua colaboradora.

El expediente incorpora antecedentes laborales, cotización, informes médicos, profesión y contingencia. El equipo de valoración de incapacidades —EVI— formula dictamen-propuesta sobre:

- existencia y grado;
- contingencia determinante;
- plazo de revisión;

- lesiones permanentes no incapacitantes;
- necesidad de tercera persona;
- relación con el puesto y otras cuestiones atribuidas.

El dictamen no es la resolución. La dirección provincial del INSS decide, motiva, notifica y abre vías de reclamación.

18.1. Profesión, limitaciones y prueba

La valoración relaciona capacidad residual con tareas fundamentales. Importan:

- exploración y pruebas objetivas;
- evolución y respuesta terapéutica;
- exigencias físicas, cognitivas, sensoriales y relacionales;
- riesgos para sí o terceros;
- frecuencia e intensidad de síntomas;
- posibilidad real de sostener rendimiento, asistencia y profesionalidad.

No se reconoce automáticamente por porcentaje de discapacidad, dependencia, diagnóstico grave o resolución de prevención. Son valoraciones con finalidades diferentes, aunque sus informes aporten prueba.

19. Revisión de la IP

Toda resolución que reconozca o confirme un grado debe señalar desde cuándo puede instarse revisión por mejoría o agravación. Ese plazo vincula a todos los legitimados mientras no se alcance la edad ordinaria de jubilación.

Excepciones:

- si el pensionista trabaja por cuenta propia o ajena, el INSS puede revisar antes;
- si existe error de diagnóstico, la revisión puede hacerse en cualquier momento antes de la edad límite.

La revisión puede mantener, aumentar, reducir o extinguir el grado y transformar la prestación. No castiga a quien mejora: adapta el derecho a su capacidad actual. Debe existir procedimiento, prueba médica y resolución motivada.

Cumplidos 67 años, la pensión cambia de denominación a jubilación y, como regla, cesa la revisión ordinaria por IP. El cambio nominal no altera la cuantía ni las condiciones que se venían disfrutando.

20. Casos prácticos integrados

Caso 1. Baja común de 30 días

Una trabajadora mensual con base anterior de 1.500 euros acredita carencia y enferma. BR diaria: 50 euros. Días 1 a 3: sin subsidio. Días 4 a 20: $17 \times 30 = 510$ euros, a cargo empresarial del 4 al 15 y entidad desde el 16. Días 21 a 30: $10 \times 37,50 = 375$ euros. Total legal: 885 euros, sin mejoras.

Caso 2. Donación

Un donante entra en baja el día de una prueba preparatoria necesaria y continúa hasta curación. No se exige carencia, la entidad paga desde ese mismo día y la cuantía es 100 por ciento de la BR común. No corresponde aplicar tres días de espera ni 60 por ciento.

Caso 3. Recaída

Tras 200 días de IT, existe alta. Cien días después surge baja por patología similar: se acumula y el proceso comienza funcionalmente en el día 201. Si la nueva baja fuese menstruación incapacitante secundaria, cada proceso sería nuevo por excepción.

Caso 4. Carencia de IP

Una persona de 28 años causa pensión por enfermedad común. Desde los 16 al hecho causante han transcurrido 12 años; debe acreditar una tercera parte, 4 años. Si tuviera 32, se aplicaría una cuarta parte desde los 20, pero el mínimo legal elevaría la exigencia a 5 años.

Caso 5. Trabajo con IPT

Una conductora profesional recibe IPT por pérdida visual incompatible con conducción y obtiene trabajo administrativo. El salario es compatible si las tareas no coinciden. Si volviera a conducir profesionalmente, surgiría incompatibilidad y una base clara para revisión.

Caso 6. Adaptación del puesto

Una persona recibe IPT y expresa en diez días su voluntad de continuar. La empresa evalúa ajustes y encuentra una vacante compatible dentro de tres meses. El contrato no se extingue automáticamente; se materializa el cambio y el INSS aplica compatibilidad o suspensión de la pensión según las nuevas funciones.

21. Errores frecuentes

1. Equiparar enfermedad con IT. Hace falta impedimento laboral y asistencia.
2. Decir que la duración máxima siempre es 365 días. Puede alcanzar 545 y prolongar efectos hasta el límite total de 730.
3. Tratar toda nueva baja dentro de 180 días como recaída. Debe ser la misma o similar patología.
4. Acumular menstruaciones incapacitantes. Cada proceso es nuevo.
5. Exigir 180 días a todo proceso común. Las situaciones especiales tienen dispensas o carencia propia.
6. Aplicar 100 por ciento a todas las situaciones especiales. Solo la donación tiene esa cuantía específica.
7. Poner siempre tres días sin subsidio. Menstruación y donación nacen el día inicial.
8. Atribuir a la mutua un alta común ordinaria. Puede proponerla; sus competencias de alta directa se concentran en profesionales.
9. Creer que al día 365 el INSS debe dictar prórroga expresa. La prórroga opera si no hay alta.
10. Mantener cotización durante los 90 días de calificación. La obligación cesa en ese período.
11. Considerar vitalicia igual a irreversible. La IP es revisable.
12. Usar el diagnóstico para fijar grado. Se valora limitación funcional y profesión.
13. Llamar gran invalidez a la categoría actual. Desde mayo de 2025 es gran incapacidad.
14. Exigir tratamiento previo en todo caso. Desde 2024 existe excepción legal.
15. Olvidar la carencia específica de 1.800 días para parcial común.
16. Aplicar directamente 55 por ciento al promedio 96/112. En enfermedad común puede existir ajuste previo por carrera.

17. Calcular la pensión profesional con la base del mes anterior.
18. Sumar LPNI e IP por la misma lesión.
19. Afirmar que la IP extingue automáticamente el contrato. La Ley 2/2025 exige voluntad, ajustes y decisión motivada.
20. Mantener absoluta mientras existe trabajo incluido en un régimen. La pensión se suspende; el complemento de gran incapacidad constituye excepción.

Antecedentes de examen y puntos especialmente preguntados

El análisis se ha realizado sobre las preguntas oficiales de acceso libre publicadas para las convocatorias 2023, 2024 y 2025, con fecha de corte 30 de julio de 2026. La base conserva las variantes necesarias para la trazabilidad, pero el recuento de frecuencia usa una sola variante canónica por sesión, de modo que los modelos o colores que únicamente permutan el orden o las opciones no se cuentan dos veces. Este criterio permite medir repeticiones reales entre sesiones sin inflar artificialmente la presencia del tema.

Indicador	Resultado para S08
Preguntas canónicas atribuidas	32
Distribución por año de examen	2024: 6, 2025: 19, 2026: 7
Teóricas / prácticas	18 / 14
Preguntas de reserva	3
Anuladas / con respuesta modificada	1 / 0
Enunciados con excepción, negación o respuesta incorrecta	2

Normas que más aparecen: texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (12); Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (3); Real Decreto 1300/1995 (1).

Artículos o preceptos más repetidos: 173 (3); 174 (2); 169.1 (1); 2 (1); 169 (1); 195 (1); 201 (1); 23 (1).

Formas de pregunta predominantes: Incapacidad (15); Plazos (5); Personas beneficiarias (4); Requisitos (3); Órganos (2).

Patrones observados

- 2025, supuesto 16, reserva: ¿Es compatible la pensión de D. ANTONIO BERMEJO con el puesto de trabajo que le han ofrecido?
- 2025, supuesto 17, reserva: Victoria trabaja como fisioterapeuta por cuenta ajena. Tras una caída esquiando, se ha fracturado el cúbito y el radio del brazo derecho. El facultativo médico ha estimado un periodo de duración de baja...
- 2025, supuesto 18, reserva: Eduardo se encuentra en un proceso de incapacidad temporal como consecuencia de un accidente de tráfico desde el 5 de mayo de 2024. Una vez agotado el plazo de duración de 365 días, la inspección médica del...
- 2024, supuesto 9: ¿Qué órgano ha tenido necesariamente que emitir el alta médica de Alejandro Alonso?
- 2024, supuesto 10: ¿Hasta qué día puede Alejandro Alonso presentar la disconformidad ante el alta médica recibida?
- 2025, supuesto 10: Siempre que tuviera derecho, ¿qué día comenzará el derecho al abono del subsidio de incapacidad temporal?

Cómo trasladarlo al estudio

1. Priorice la literalidad útil. Memorice la regla, su artículo y la excepción, pero comprenda antes quién actúa, sobre qué supuesto y con qué plazo.
2. Entrene las negaciones. En este tema se han localizado 2 enunciados con fórmulas como «INCORRECTA», «NO», «salvo» o «excepto». Subraye siempre el mandato antes de leer las opciones.
3. Separe regla estable y dato anual. Cuando intervengan cuantías, bases, tipos, edades o porcentajes, anote el año de referencia y contraste la cifra con la norma consolidada vigente.
4. Use las anulaciones como señal de riesgo. Una pregunta anulada no desaparece del aprendizaje: suele revelar una redacción ambigua, una reforma reciente o dos preceptos que deben diferenciarse.
5. No confunda frecuencia con seguridad de aparición. El recuento describe el corpus disponible; no garantiza la distribución de una convocatoria futura ni permite excluir epígrafes poco preguntados.

22. Tabla final de cifras

Cifra	Significado
180 en 5 años	Carencia de IT por enfermedad común
$365 + 180 = 545$ días	Duración ordinaria y prórroga
90 días	Evaluación ordinaria de IP tras 545
730 días	Máximo IT más demora de calificación
180 días	Ventana general de recaída
$180 + 180$ días	Observación por enfermedad profesional
60 % / 75 %	Porcentajes de IT común
75 %	IT profesional
100 %	Donación
1.800 en 10 años	Carencia de parcial común
24 mensualidades	Indemnización de parcial
55 % / 75 %	Total ordinaria / cualificada
100 %	Absoluta
45 % base mínima + 30 % última base	Complemento de gran incapacidad
10 días / 3 meses	Voluntad del trabajador / actuación empresarial tras IP

23. Normativa y fuentes oficiales

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, TRLGSS, artículos 169 a 176 y 193 a 203: BOE, texto consolidado (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724>).
- Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, gestión y control de IT: BOE, texto consolidado (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-7684>).
- Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, competencias y procedimiento de incapacidad laboral: BOE, texto consolidado (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-19848>).

- Decreto 3158/1966 y Orden de 15 de abril de 1969, en lo que conservan vigencia para cuantías y grados: BOE, Decreto (<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-21121>) y BOE, Orden (<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-399>).
- Ley 6/2024, de 20 de diciembre, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante: BOE (<https://www.boe.es/eli/es/l/2024/12/20/6>).
- Ley 3/2024, de 30 de octubre, mejora de calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades complejas: BOE (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-22438>).
- Ley 2/2025, de 29 de abril, extinción contractual por incapacidad permanente: BOE, texto consolidado (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-8567>).
- Real Decreto Legislativo 2/2015, Estatuto de los Trabajadores, artículos 45, 48 y 49: BOE, texto consolidado (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430>).
- Portal de incapacidad de la Seguridad Social: prestaciones y pensiones (<https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores>).
- Convocatoria y programa: BOE-A-2025-27158 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-27158).
- Cuestionarios y plantillas oficiales: Seguridad Social (<https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/9950/88beb45d-ca83-4bab-8162-f94ef2894562/e0c83707-3358-47a9-94d7-508221dad233>).